Commission technique sur la gestion d'une victime sur corde

Le 23/10/13 Premier jour avec l'IFREMMONT

Réunion avec les membres du CTGVC du DPMC et de l'IFREMMONT plus deux membres du GRIMP.

Synthèse sur les derniers travaux effectués sur le SDH depuis sa découverte.

- Le type de harnais
- Le temps de suspension
- L'immobilité
- Le malaise dans tous les cas malgré les positions (tps change)
- Pas de compression des artères fémorales
- Mortalité plusieurs jours après la suspension

Explication des axes de recherche médicaux pouvant expliquer le SDH.

- Manque de flux sanguin dû à l'immobilité, notamment des membres inférieurs.
- Bascule de la tête provocant un changement de TA.
- Etat physique de la victime.
- Précaution de décrochage après une longue suspension.

Mise en place d'un observatoire de témoignage d'incident et d'accident à grande échelle géré par l'IFREMMONT, afin de garantir un anonymat, et le respect du secret médical.

- Sexe
- Etat physique avant accident
- Age
- IMC
- Type de harnais
- Fumeur autre addiction/traitement en cours
- Niveau de formation
- Accident/incident
- Jour/nuit
- Type de travail
- Temps de suspension
- Milieu confiné
- Chute/choc/rien
- Traumatisme ?
- EPI
- Point d'attache (sternal, ventral, dorsal)
- Sellette ?
- ICS/CS
- Position CS
- Position ICS

Choix des positions à tester.

- Sur ventral
- Sur sternal
- Sur dorsal
- En position du fœtus

Le 24/10/13 Deuxième jour avec l'IFREMMONT

Protocole des testes

Premiers essaie de testes avec le doppler transcranien.

1. Ventral conscient



0’

2. Ventral inconscient



3’

3. Position secours connecteur sternal

6’

4. Position 3 + Sellette fesse

9’



5. Position 3 + Sellette Genoux

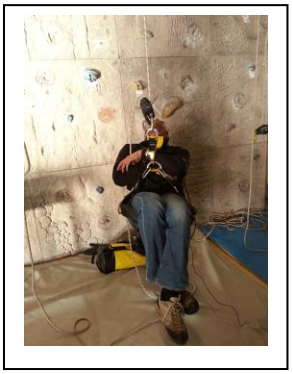


6. Position sur sternal et sellette genoux (fœtal) 15’



7. Position 6 avec main sur thorax

18’



8. Position 7 avec maintien tête

21’



9. Allongé au sol

24’

1) Position sternal conscient

3’



2) Position sternal inconscient

6’



3) Au sol

9’

Position dorsal conscient

3’



Au sol

9’



Position dorsal inconscient

6’



Le 25/10/13 Troisième jour avec l'IFREMMONT

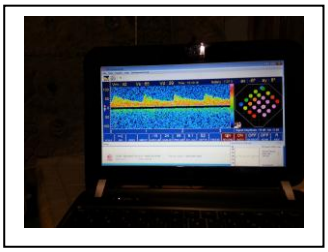
Tests complet sur 3 positions pendant 3 minutes chacune;

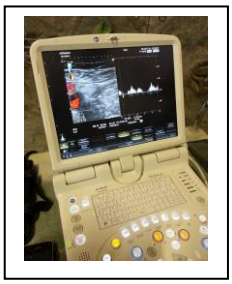
- Position de travail puis au sol
- Position inconscient sur ventral puis au sol
- Position fœtal (sternal) avec maintien tête et sellette puis au sol



Tests effectué ;

- Echographie fémoral
- Doppler transcranien
- Tension Artériel





En résumé ;

- Premier tests concluant sur l'intérêt de l'étude. L'ifremmont va monter un dossier au comité d'éthique pour effectuer un test à grande échelle.
- Mise en place d'un observatoire anonyme. L'ifremmont recherche un médecin pour effectuer sa thèse sur le sujet.
- Recherche sur un prototype qui permet le maintien tête.
- Formation pour les formateurs sur le côté médical et secours sur corde (signe annonciateur, SDH,) à étudier pour le printemps 2014. Travaux intéressant pour l'élaboration d'un SST corde.
- Travail sur la position dite du fœtus. Un travail technique sur la mise en place et progression avec une victime en position de fœtus.

Retour de l'analyse sous 10 jours. L'étude approfondie des données sera plus longue.

Conclusion ;

Cette première expérience démontre que cette recherche est indispensable. Même si nous attendons le retour d'analyse, nous pouvons déjà travailler à améliorer la gestion d'une victime.

Les différente positions testée par l'équipe montre que la position de fœtus est la plus apte à maintenir une victime en suspension.

Les points clefs ;

- Sellette sous les genoux
- Maintien de la tête en position neutre (par le casque et non par la nuque !)
- Bras ramené sur le buste
- Maintien de la victime par le sternal



A court terme nous pouvons déjà mettre en place dans les référentiels les gestes suivants pour la gestion d'une victime sur corde, et éviter le transport d'un sac à patate.

- Pousser la sellette sous les genoux
- En cas de décrochage sur bloqueur, mettre le descendeur sur point sternal en utilisant la corde de sécurité.
- Positionner les bras de la victime sur son abdomen.
- Effectuer un maintien tête avec le matériel à disposition (pédale, sangle, cordelette,…) entre le pontet et le casque.